



NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 4to Semestre 2025A		CÓDIGO:	NIVEL DE PRÁCTICA:
NOMBRE DEL DOCENTE : Samuel Humberto Palacio Peña		ESCENARIO DE PRÁCTICA:	NOTA:
ESPECIALIDAD:	CIRUJANO:	FECHA:	
NOMBRE DEL PACIENTE:		NÚMERO HISTORIA CLÍNICA:	EDAD DEL PX:

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO A REALIZAR: URETROPLASTIA

PROCESO DE INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA

• ETAPA DE PLANEACIÓN:

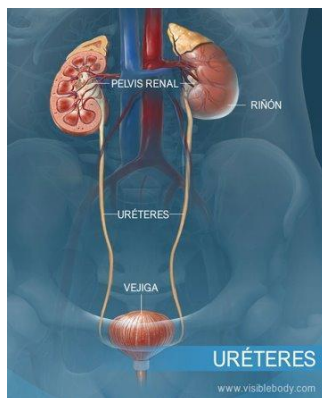
1.1. Objetivo Quirúrgico: (Hacer descripción)

Reparación de una malformación, lesión o corte de uno o dos uréteres y también para corregir lo que es la estenosis uretral.

1.2. Anatomía y fisiología: (Hacer gráfico y descripción).

Los uréteres son tubos largos y delgados formados de músculo liso. En los adultos, los uréteres miden 25-30 cm de largo, aproximadamente la longitud de una regla de 12 pulgadas.

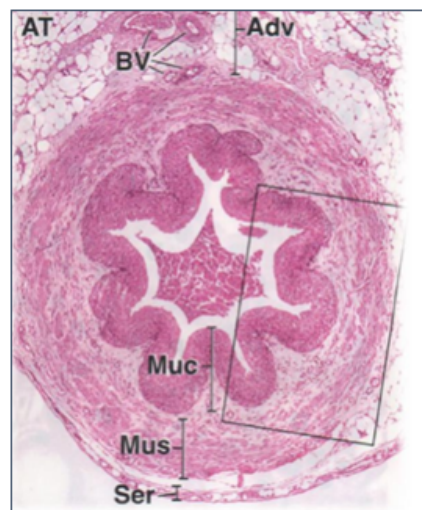
Los uréteres empujan cada pequeña cantidad de orina en forma de ondas de contracción, a baja presión. En la vejiga, cada uréter atraviesa la pared de la vejiga por una abertura que se cierra cuando la vejiga se contrae para evitar que la orina retroceda.





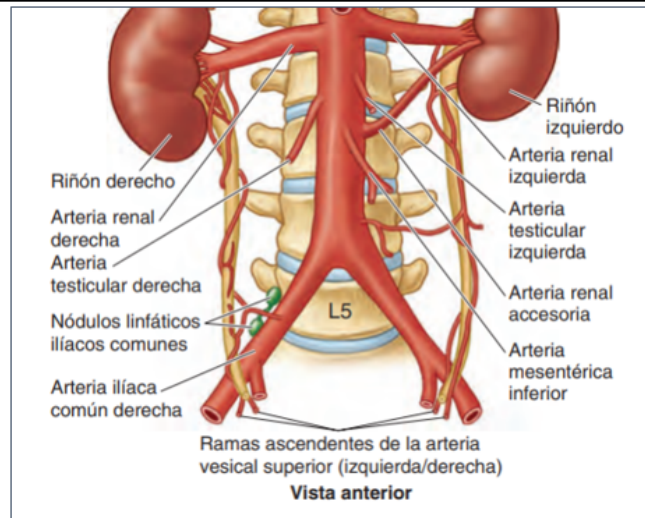
Capas

El uréter está compuesto por tres capas principales organizadas de adentro hacia afuera. La capa más interna es la mucosa, formada por un epitelio de transición (urotelio) que permite la distensión, y una lámina propia de tejido conectivo. Esta capa está en contacto directo con la orina. La siguiente es la capa muscular, compuesta por músculo liso dispuesto en dos capas: una longitudinal interna y una circular externa; en el tercio inferior del uréter puede haber una tercera capa longitudinal externa. Esta capa es responsable del movimiento peristáltico que impulsa la orina hacia la vejiga. Finalmente, la capa más externa es la adventicia, constituida por tejido conectivo laxo que contiene vasos sanguíneos, linfáticos y nervios, y que fija el uréter a las estructuras circundantes.



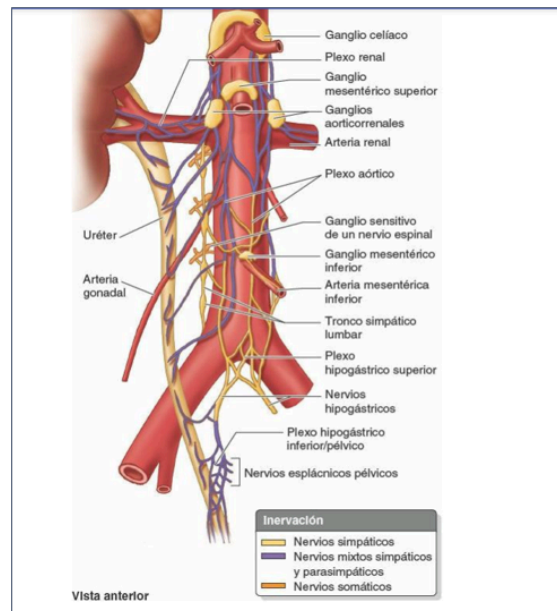
Irrigación uréter

La irrigación del uréter es segmentaria y proviene de varias arterias a lo largo de su trayecto desde el riñón hasta la vejiga. En el tercio superior, el uréter recibe ramas de la arteria renal; en el tercio medio, es irrigado por ramas de la arteria gonadal (testicular u ovárica), de la aorta abdominal y, en algunos casos, de la arteria iliaca común; en el tercio inferior, la irrigación proviene principalmente de ramas de la arteria iliaca interna, como la arteria vesical superior, arteria uterina en mujeres o la arteria vesical inferior en hombres. Las ramas arteriales forman una red en la adventicia del uréter antes de penetrar hacia las capas internas. Esta irrigación segmentaria es importante clínicamente, especialmente en cirugías, ya que el uréter depende de múltiples fuentes vasculares a lo largo de su trayecto.

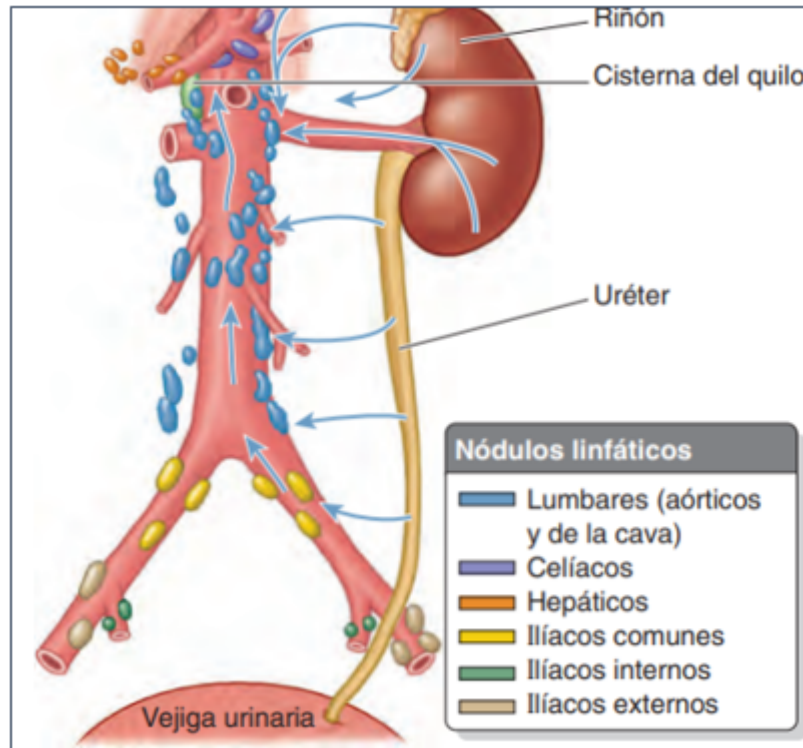


Inervación

La inervación del uréter es proporcionada por fibras nerviosas del sistema nervioso autónomo, tanto simpáticas como parasimpáticas. Las fibras simpáticas provienen de los plexos renal, aórtico, hipogástrico superior e inferior, y tienen un papel en la modulación del dolor y del tono del músculo liso ureteral. Las fibras parasimpáticas se originan principalmente en el nervio vago (para la parte superior del uréter) y en los nervios espláncnicos pélvicos (S2-S4) para el tercio inferior. La transmisión del dolor ureteral viaja a través de las fibras simpáticas hasta los ganglios espinales toracolumbares (T10-L2), lo que explica por qué el dolor por cólico renal puede irradiarse a la espalda, flanco, abdomen o incluso a los genitales.



Drenaje Linfático uréter



FISIOLOGÍA

La fisiología del uréter se basa en su función principal de transportar la orina desde la pelvis renal hasta la vejiga urinaria de manera continua y controlada. Este proceso se realiza mediante contracciones peristálticas del músculo liso ureteral, las cuales son rítmicas y espontáneas, iniciadas por células marcapaso ubicadas cerca de la pelvis renal. Las ondas peristálticas se producen entre 1 y 5 veces por minuto, dependiendo del volumen de orina. El uréter está compuesto por una capa muscular con disposición longitudinal interna y circular externa (y una capa longitudinal externa en el tercio distal), lo que permite un movimiento eficaz de la orina. Su control es autónomo, con innervación simpática que regula el tono del músculo liso y transmite el dolor, e innervación parasimpática que estimula la actividad contráctil. Además, el urotelio, un epitelio de transición que recubre el interior del uréter, actúa como barrera impermeable y detecta el estiramiento, ayudando a regular las contracciones. Finalmente, en su porción terminal, el uréter atraviesa de forma oblicua la pared de la vejiga, formando un mecanismo valvular que evita el reflujo de orina hacia los uréteres cuando la vejiga se llena.



1.3. Lista de chequeo:

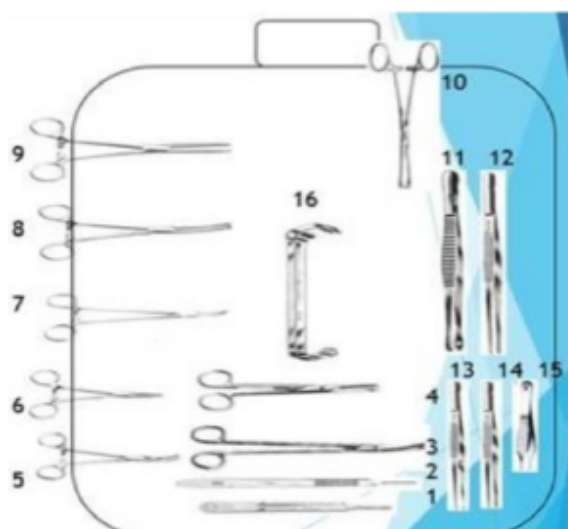
INSTRUMENTAL	EQUIPOS / DISPOSITIVOS MEDICO	SUTURAS Y AGUJAS	FARMACOS Y SOLUCIONES
Canasta general	Paquete de ropa	Nylon o monofilamento 2/0 o 3/0 Sutura absorbible 2/0	Solución salina
Canasta vascular	Electro		
Canasta de tórax	Pera	Poliglactin 910 1/0	
Separadores de vena	Cauchos de succión	sutura tipo Catgut 4/0 5/0	
Lima	Drenes en cigarrillo		
	Compresas	Sutura vascular 5/06/0 (reserva)	
	Guantes		
	Sondas nasogástricas n 6-8		
	Torundas		
	Hojas de bisturi 20/15		
	Gasas		
	Apósitos		



- ETAPA DE ORGANIZACIÓN:

- Arreglos de mesas de mayo y reserva (realizar esquema).

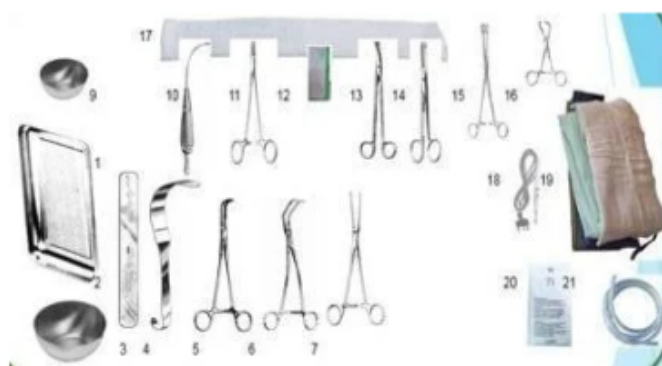
MESA DE MAYO



1. Mango de bisturí 4 - Hoja de bisturí #20
2. Mango de bisturí 3 - Hoja de bisturí #15
3. Tijeras de Metzemaum
4. Tijeras de Mayo recta
5. Pinzas Kelly curva
6. Pinzas Kelly recta
7. Pinzas Kelly Adson
8. Pinzas Roc hester curva
9. Pinzas Rochester recta
10. P inzas Allix
11. P inza de Disección Rusa
12. P inza de Disección sin garra larga
13. P inza de Disección con garra larga
14. P inza de Disección sin garra corta
15. D isección Adson con garra
16. S eparadores de Farabeuf

MESA DE RESERVA

1. Equipo General
2. Coc a
- 3.Valva Maleable
4. deaver Angosto
5. Pinzas Cístico
- 6.Clamps de Satinsky
- 7.Clamps de Debakey
8. Coca con suero
9. Cánula de yankawer
- 10.Portaagujas
- 11.Suturas
- 12.Tijeras de Metzemaum Fina larga
- 13.Tijeras de Mayo larga
- 14.Pinza de Foester
- 15.pinza de campo de Backhouse
- 16.Compresa
- 17.Lapicero del Electrobisturí
- 18.Paquete de ropa
- 19.Guantes
- 20.Caucho de succión





2.2. Posición del paciente (Nombre y gráfico):

Decúbito lateral





2.3. Ubicación del Equipo Quirúrgico (realizar gráfico):



- ETAPA DE EJECUCIÓN:

o Anestesia (escribir el tipo de anestesia):

Anestesia General

o Incisión (escribir el tipo de abordaje y el nombre de la incisión):

subcostal lateral



- o **Proceso Quirúrgico (Describir los pasos principales de la técnica médico quirúrgica con el instrumental a usar).**

TÉCNICA QUIRÚRGICA	INSTRUMENTAL A UTILIZAR
Anestesia general	Carrito de anestesia
Colocación de campos quirúrgicos Inicio de conteo compresas-torundas	Paquete de ropa Compresas-torundas
Se incide piel tcs Realizamos hemostasia	Bisturí #4 Hoja de bisturí # 20 Pinza Kelly Electrobisturí
Visualizamos fascia se incide con electrobisturí junto con el músculo y los separamos visualizamos la cavidad retroperitoneal y colocamos los separadores de deaver	Separadores de farabeuf Electrobisturí Separadores de deaver
Se localiza el uréter y se secciona	Tijeras de metzembaum y pinza de disección vascular
Se repara con dren en cigarrillo para localizar así la estenosis	Dren en cigarrillo

FORMATO DE INFORME SEMANAL DE LA PRACTICA FORMATIVA
FORMATO RECORD DE ASISTENCIA A CIRUGIA - PRACTICA FORMATIVA
IQX-FT-024-UDES